Tema: Atenção à gestante infectada pelo vírus da hepatite B **Versão Nº 01**

Protocolo Nº 328 **1ª Versão:** agosto de 2022 **Atualização:** NA

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 2

OBJETIVOS 2

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 2

FLUXOGRAMA 3

ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 3

DIAGNÓSTICO 3

TRATAMENTO E PROFILAXIA 5

CRITÉRIO DE SAÍDA DO PROTOCOLO 6

MONITORAMENTO 6

REFERÊNCIAS 7

SIGLAS 7

HISTÓRICO DAS VERSÕES 8

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

INTRODUÇÃO

A hepatite B é doença viral de grande relevância. Estima-se que haja 290 milhões de indivíduos infectados mundialmente, apesar de apenas cerca de 10% receberem o diagnóstico. A hepatite B crônica pode progredir para quadros complicados como cirrose e carcinoma hepatocelular. A transmissão do vírus se dá por via hematogênica ou sexual. Denomina-se infecção crônica a persistência do antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) no soro durante mais de seis meses após a infecção aguda.

Vários são os grupos de risco que devem ser rastreados para a hepatite B. Entre eles se encontram as gestantes. Tal rastreio se justifica pela custo-efetividade e pela alta chance de se evitar a transmissão ao recém-nascido quando a mãe recebe o diagnóstico em tempo hábil.

Acredita-se que cerca de 90% dos infectados eliminem o vírus ainda na fase aguda e, destes, a maioria não desenvolve sintomas. Cerca de 40% desenvolverão a forma ictérica, e 1% a forma fulminante.

Entretanto, quando ocorre a infecção vertical, o risco de desenvolvimento de doença crônica é de 90%. A contaminação do embrião ou feto pode ocorrer em qualquer fase da gestação, mas é mais frequente durante o parto. Os fatores de risco para transmissão vertical são: HBeAg positivo, níveis de HBV DNA maiores que 10^6 UI/ml, e coinfecção por HIV. Há também fatores menores, como idade materna menor que 25 anos e origem asiática.

OBJETIVOS

O objetivo deste protocolo é definir as condutas referentes às rotinas de pré-natal e parto de gestantes infectadas pelo vírus da hepatite B.

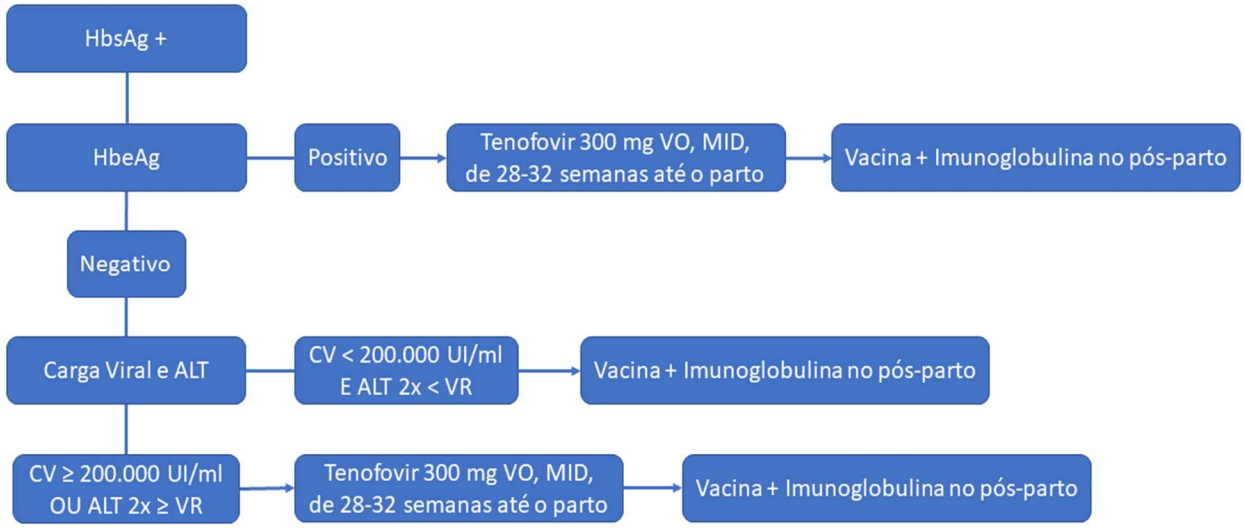
CRITÉRIOS DE ADMISSÃO

Pacientes gestantes, em atendimento no Hospital das Clínicas da UFMG, com diagnóstico de infecção pelo vírus da hepatite B.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

FLUXOGRAMA

Recomendações de profilaxia em gestantes infectadas pelo vírus da Hepatite B



ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

Médico obstetra	– Primeiro atendimento, condução clínica, solicitar as interconsultas necessárias.
Equipe de enfermagem	– Monitorar, garantir presteza na realização do atendimento.
Farmácia clínica	– Garantir presteza no fornecimento de medicamentos necessários ao atendimento.
Assistente social	– Providenciar interface entre a equipe hospitalar e da saúde da família para o controle pós-alta.
Médicos de outras especialidades	– Atender às interconsultas solicitadas pelo obstetra.

DIAGNÓSTICO

*Rastreamento: t*oda gestante deve ser testada para hepatite B, com realização do HBsAg no primeiro e no último trimestre.

Manifestações clínicas

A doença aguda pode se manifestar em 60 a 90 dias após a exposição, através de náuseas, vômitos, febre, dor abdominal, colúria, acolia fecal, icterícia, hepato e esplenomegalia. Há aumento de ALT e, em caso de progressão para formas crônicas, diferentes níveis de comprometimento hepático.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Interpretação de marcadores sorológicos

A presença do HBsAg indica infecção, seja aguda ou crônica. Todo indivíduo HBsAg positivo é infectante. O HBV DNA é uma medida da carga viral, e pode ser detectado no soro antes do HBsAg. Anti-HBc (IgM e IgG) são anticorpos contra antígenos core virais, e aparecem inicialmente na doença aguda, pouco depois do surgimento do HBsAg. O anti-HBc IgM desaparece em cerca de 6 meses, enquanto o IgG permanece presente em indivíduos que já tiveram a doença, mantendo o anti-HBc total positivo. Às vezes, o anti-HBc pode ser o único marcador de infecção presente. A presença de HBeAg é indicativa de replicação viral e alta infectividade. A presença de anti-HBs indica imunidade, tanto decorrente de doença passada quando de vacinação ou uso de imunoglobulina.

Tabela 1 – Significado clínico dos marcadores sorológicos da hepatite B:

Teste	Resultado
HBsAg	Presença do antígeno de superfície do vírus da hepatite B (VHB). Significa presença do vírus, em infecção aguda ou crônica.
Anti-HBs	Descreve imunidade contra o vírus, desenvolvida após infecção ou imunização.
Anti-HBc IgM	Presença do antígeno do *core* viral, IgM. Infecção recente pelo VHB
Anti-HBc IgG	Presença do antígeno do *core* viral, IgG. Infecção antiga ou estágio final da infecção aguda.
HBeAg	Presença de replicação viral.
Anti-HBe	Infecção prévia ou crônica sem replicação viral.

Tabela 2 - Fases da infecção segundo os resultados dos exames:

Teste	Resultado	Interpretação
HBsAg	-	Sem infecção atual nem prévia e susceptível.
Anti-HBc	-	
Anti-HBS	-	
HBsAg	-	Infecção prévia, imune
Anti-HBc	+	
Anti-HBS	+	
HBsAg	-	Imune devido a vacinação
Anti-HBc	-	
Anti-HBS	+	

A tabela continua

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

HBsAg	+	Infecção aguda
Anti-HBc	+	
Anti-HBc IgM	+	
Anti-HBS	-	
HBsAg	+	Infecção crônica
Anti-HBc	+	
Anti-HBc IgM	-	
Anti-HBS	-	
HBsAg	-	Quatro possíveis interpretações: – Em recuperação após infecção aguda – Infecção prévia com titulação do anti-HBs muito baixa – Anti-HBC falso positivo – Infecção crônica com titulação do HBsAg muito baixa
Anti-HBc	+	
Anti-HBS	-	

TRATAMENTO E PROFILAXIA

- Todas as gestantes com diagnóstico de hepatite B deverão ser acompanhadas em pré-natal de alto risco e encaminhadas para acompanhamento conjunto em Ambulatório de Hepatites Virais.
- Não há indicação de tratamento específico para a infecção aguda por hepatite B, além da terapia de suporte.
- A terapia antiviral está indicada para doentes crônicos com alto risco de progressão para formas graves.
- A vacinação contra a hepatite B é parte do Calendário Nacional de Imunizações, e está disponível para todas as crianças a partir do nascimento, bem como para indivíduos não vacinados de qualquer idade. É recomendada a vacinação de todos os recém-nascidos, independentemente do status sorológico materno, com a 1ª dose nas primeiras 48 horas de vida, a 2ª aos dois meses e a 3ª aos seis meses de vida.
- Crianças nascidas de mães portadoras do VHB deverão receber, além da vacina, a imunoglobulina hiperimune, por via intramuscular, em sítio diferente da aplicação da vacina, ainda nas primeiras 12 horas de vida. Elas ainda receberão doses adicionais e serão testadas, de acordo com as recomendações da Pediatria. Após adequada profilaxia, as chances de a criança desenvolver infecção variam entre 0,7 e 1,1%.
- As gestantes susceptíveis devem ser vacinadas contra a hepatite B, ainda no início da gravidez.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- Gestantes com HBeAg positivo devem ser tratadas no último trimestre, assim como aquelas com HBV DNA maior que 200 000UI/ml. O agente preferencial é o tenofovir (TDF), iniciado entre 28 e 32 semanas e mantido até o parto ou até três meses no pós-parto.

- A transmissão do VHB ocorre de forma mais frequente através do contato de pele não intacta e mucosas com secreções corporais contendo sangue. A transmissão através de secreção nasofaríngea, urina, fezes, vômito, suor ou escarro é improvável, assim como através do leite materno, pois todos esses fluidos contêm baixas quantidades de vírus.

- Por essa razão, o aleitamento materno não está contraindicado em mulheres com hepatite B e a decisão quanto à sua indicação deve ser compartilhada com a mãe, após os esclarecimentos sobre riscos e opções alternativas de amamentação. Da mesma forma, a via de parto pode ser de indicação obstétrica.

CRITÉRIO DE SAÍDA DO PROTOCOLO

- Exclusão do diagnóstico de hepatite B.
- Ocorrência do parto.

MONITORAMENTO

- Número de gestantes em atendimento no HC-UFMG com diagnóstico de hepatite B.
- Número de crianças nascidas no HC-UFMG com diagnóstico de hepatite B por transmissão vertical.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os participantes declaram não haver conflito de interesse.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

REFERÊNCIAS

Barros MMO, Ronchini KROM, Soares RLS. Hepatitis B and C in pregnant women attended by a prenatal program in an universitary hospital in Rio de Janeiro, Brazil: retrospective study of seroprevalence screening. **Arquivos de Gastroenterologia**, v. 55, n.3, 2018.

Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. **Recomendations and Reports**, v.67, n.1, 2018.

Ferraz ML *et al*. Brazilian Society of Hepatology and Brazilian Society of Infectious Diseases Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Hepatitis B. **Brazilian Journal of Infectious Diseases**, v.24, n.5, p.434-451, 2020.

Sanson MCG *et al*. Prevalência e perfil epidemiológico da Hepatite B em gestantes: um estudo populacional em uma cidade da Amazônia Ocidental brasileira, no período de 2007 a 2015. **Revista Brasileira de Saúde Materno infantil**, v.18, n.4, p. 723-733, 2018.

SIGLAS

Anti-HBc IgG	Imunoglobulina G contra o antígeno do *core* viral do VHB
Anti-HBc IgM	Imunoglobulina M contra o antígeno do *core* viral do VHB
Anti HBe	Anticorpo contra o antígeno E do vírus da hepatite B
Anti-HBs	Anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B
HBeAg	Antígeno E do vírus da hepatite B
HBsAg	Antígeno de superfície do vírus da hepatite B
HBV DNA	DNA do vírus da hepatite B
VHB	Vírus da hepatite B

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

HISTÓRICO DAS VERSÕES

1ª versão

- Elaborada em abril de 2022 por: Mário Dias Corrêa Júnior e Marina Fistarol.
- Responsável técnico: Mário Dias Corrêa Júnior.
- Aprovada em agosto de 2022 por Luciana Cristina dos Santos Silva, gerente de Atenção à Saúde e diretora técnica.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).